



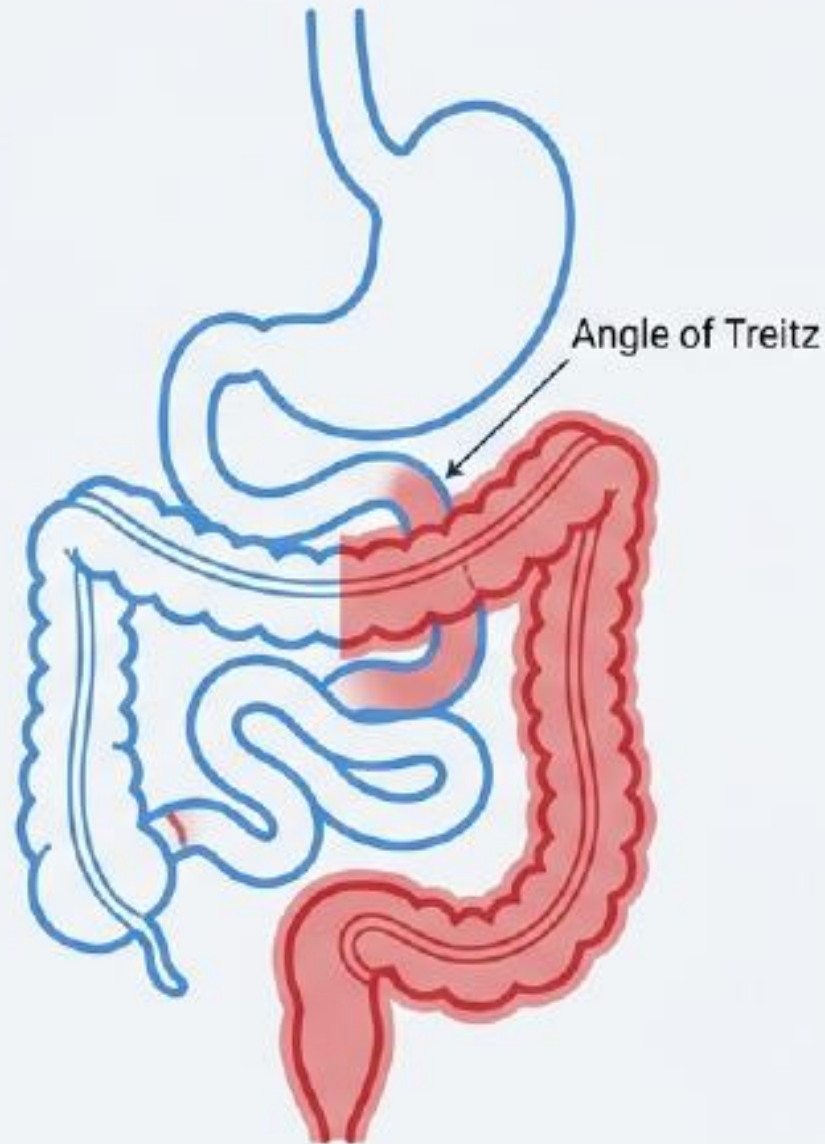
Conduite à Tenir Devant une Hémorragie Digestive Basse

Le parcours clinique pour l'externe de 4^{ème} année

Université de Constantine 3 – Faculté de Médecine
Année Universitaire 2025-2026

Dr. Belmili N.

Définir l'Hémorragie Digestive Basse (HDB)



Définition: Saignement ayant pour origine une lésion située en **aval de l'angle de Treitz**.



Fréquence: **20 cas** pour 100 000 habitants par an.



Origine: Le plus souvent d'origine **colique**, diagnostiquée par **coloscopie**.



Pronostic: Généralement **favorable**, avec un **arrêt spontané** fréquent du saignement.



Le défi: Dans 10% des cas, le saignement est d'emblée **persistant ou récidivant**, nécessitant des méthodes hémostatiques avancées (endoscopie, radiologie interventionnelle, chirurgie).

The background is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic-looking water droplets of various sizes, some overlapping. A faint, circular, textured watermark is centered in the upper half of the image.

DIAGNOSTIC POSITIF

Étape 1 : Reconnaître et Différencier le Saignement

Signes Évocateurs d'une HDB

- **Facile à reconnaître:** Rectorragies, méléna (si absence de lésions hautes).
- **Difficile à reconnaître:** Tableau d'anémie aiguë évoluant vers un état de choc, ou saignement occulte révélé par une anémie chronique.

Ce qui n'est pas une HDB

- **Éliminer une fausse piste:**



- Médicaments : Charbon, sels de bismuth.



- Aliments : Betterave.
- Origine urogénitale ou cutanée.

- **Éliminer une HDB d'origine haute:**

Une hémorragie digestive haute (HDH) de grande abondance peut provoquer des rectorragies par accélération du transit.

L'intérêt de la sonde naso-gastrique et de la FOGD est primordial.

Définir le terrain : Qu'est-ce qu'une HDB ?



Définition clé :
Saignement émis par l'anus, dont l'origine est en aval de l'angle de Treitz (grêle, colon, rectum, anus).



Rectorragies

Émission de sang rouge vif non digéré. Signe typique d'une HDB.



Méléna

Émission de sang digéré, noir et fétide. Peut provenir d'une HDB (amont de l'angle colique droit) ou d'une HDH.

80%

L'arrêt est **spontané** dans **80%** des cas.

20%

Notre mission : identifier et gérer les 20% à risque et les hémorragies graves. La mortalité varie de 2 à 5%.

Vos 3 questions prioritaires face au patient



ORIGINE ?

Est-ce bien une HDB ?

- Éliminer une origine non digestive (aliments : betteraves ; médicaments : fer, charbon).
- Éliminer une hémorragie digestive haute (HDH) massive : l'intérêt de la sonde nasogastrique (SNG) si le doute persiste.



GRAVITÉ ?

Quel est l'impact hémodynamique ?

- LA PRIORITÉ ABSOLUE.
- Recherche des signes de choc : pâleur, sueurs, hypotymies, hypotension, tachycardie.



TERRAIN ?

Quel est le terrain du patient ?

- Âge, tares associées (cardiopathie, insuffisance rénale).
- Prise de médicaments : Anticoagulants, AINS.



EVALUATION DE LA GRAVITÉ ET MESURE THÉRAPEUTIQUE D'URGENCE

Priorité Absolue : Évaluer la Gravité et l'État Hémodynamique

Une urgence médico-chirurgicale nécessitant une prise en charge multidisciplinaire (réanimateurs, endoscopistes, radiologues, chirurgiens).



Critères d'évaluation de la gravité :

- **Signes cliniques de choc****: Hypotension, tachycardie, marbrures, etc.
- **Hémorragie évolutive****: Persistante ou d'emblée récidivante, particulièrement dans les premières heures.

Mesures de réanimation immédiates :

- ****Objectif n°1****: Stabiliser l'état hémodynamique.
- ****Actions****:
 - Remplissage vasculaire : SSI 9%, macromolécules.
 - Transfusion de culots globulaires si nécessaire.
 - Surveillance de l'oxygénation tissulaire et de la réponse au traitement.

La réponse immédiate : Stabiliser avant tout

Hospitalisation en USI (Unité de Soins Intensifs) pour toute hémorragie grave.



Accès vasculaires :

Mettre en place 2 voies veineuses périphériques de gros calibre.



Bilan d'urgence :

NFS, groupe/Rh/RAI, crase sanguine (TP, TCK, fibrinogène), ionogramme, urée/créatinine.



Réanimation :

Remplissage par macromolécules.
Transfusion de culots globulaires si :
Hb < 7 g/dl (tous) ou Hb < 10 g/dl (sujet âgé/cardiopathie).



Surveillance rapprochée :

Monitoring cardio-respiratoire (scope, SpO2), pression artérielle, état de conscience, diurèse (sonde urinaire).

The background is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic water droplets of various sizes, rendered with highlights and shadows to give them a three-dimensional appearance. In the center of the slide, there is a faint, large, circular watermark. It features a globe in the background with a play button icon in the center, and the text '© 2014 Pearson Education, Inc.' is visible around the perimeter of the circle.

DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE

L'enquête clinique : Les premiers indices



L'Anamnèse : Interroger pour orienter

- **Antécédents** : Diverticulose, MICI, néoplasie, polypectomie récente, prise d'AINS/anticoagulants.
- **Nature du saignement** : Rapport avec la défécation (avant, pendant, après), isolé.
- **Signes accompagnateurs** : Douleurs abdominales, modification du transit, amaigrissement, fièvre.



L'Examen Physique : Chercher les signes

- Examen abdominal complet (recherche de masse).

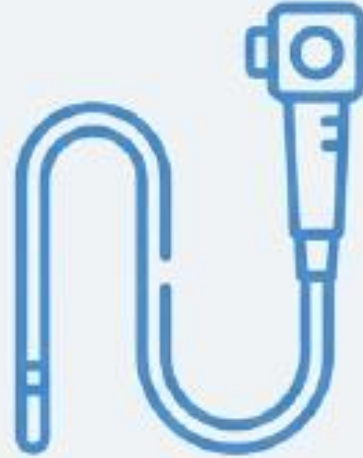
Un geste systématique et essentiel :
Le Toucher Rectal (TR). Il recherche une masse, précise les caractères du sang.

Outils Diagnostiques de Première Intention : Anuscopie et Coloscopie



Anuscopie / Recto-sigmoïdoscopie

- **Objectif:** Détecter rapidement une cause évidente de saignement bas.
- **Lésions typiquement visibles:** Hémorroïdes, fissure anale, cancer de l'anus, ulcère du rectum, proctite.
- **Limite:** Ne permet pas d'éliminer une lésion plus haute (colon d'amont).



Coloscopie

Diagnostique dans
74-90% des cas

- **L'examen clé:** Pratiquée chez un patient réanimé avec de bonnes constantes hémodynamiques.
- **Timing:** Réalisable précocement et en première intention.
- **Informations fournies:**
 - Caractère actif ou non de l'hémorragie.
 - Cause du saignement.
 - Présence de stigmates de saignement récent.
- **Responsabilité d'une lésion:** Objectivement confirmée si un saignement actif ou des stigmates d'hémorragie récente sont visibles au sein de la lésion.



La coloscopie : Voir pour savoir, voir pour agir



L'examen de choix : Réalisée en urgence (< 24h) chez un patient stable. Nécessite une préparation colique adéquate (4 à 6 litres de PEG).

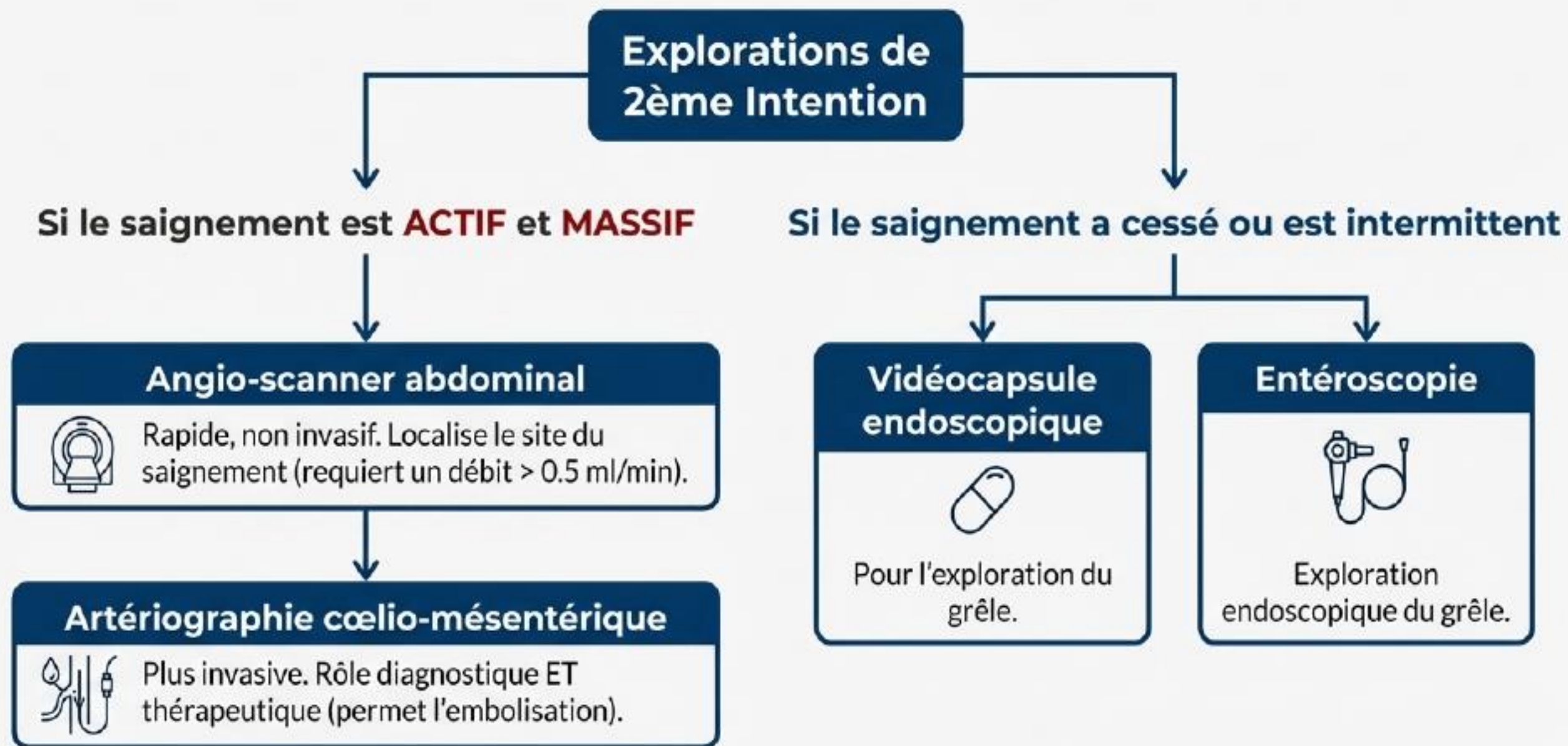
DIAGNOSTIQUE

Identifie la source du saignement dans 48 à 90% des cas.

THÉRAPEUTIQUE

Permet un geste d'hémostase immédiat (par ex. clips, coagulation au plasma argon, injections).

Plan B : Quand la coloscopie est négative ou non réalisable



En Cas d'Échec : Les Examens de Deuxième Intention

Entéroscopie



Exceptionnelle, réalisée en urgence.

Permet l'exploration du grêle proximal (duodénum distal et jéjunum proximal).

Avantages : diagnostic et potentiel thérapeutique.

Vidéo-capsule



Exploration du grêle.

Approche non invasive.

Inadéquate en cas de saignement actif important.

Angio-scanner



Méthode non invasive, utile pour le diagnostic d'HDB à la phase aiguë.

Permet de voir des signes directs/indirects d'angiodysplasie.

Signes : vascularisation localisée, un retour veineux précoce.

Artériographie cœlio-mésentérique



- **Invasive**

- **Indications:**

Saignement persistant de cause imprécise, état hémodynamique instable.

- **Condition:** Débit de saignement > 0,5-1ml/min.

- **Potentiel thérapeutique:** Embolisation.

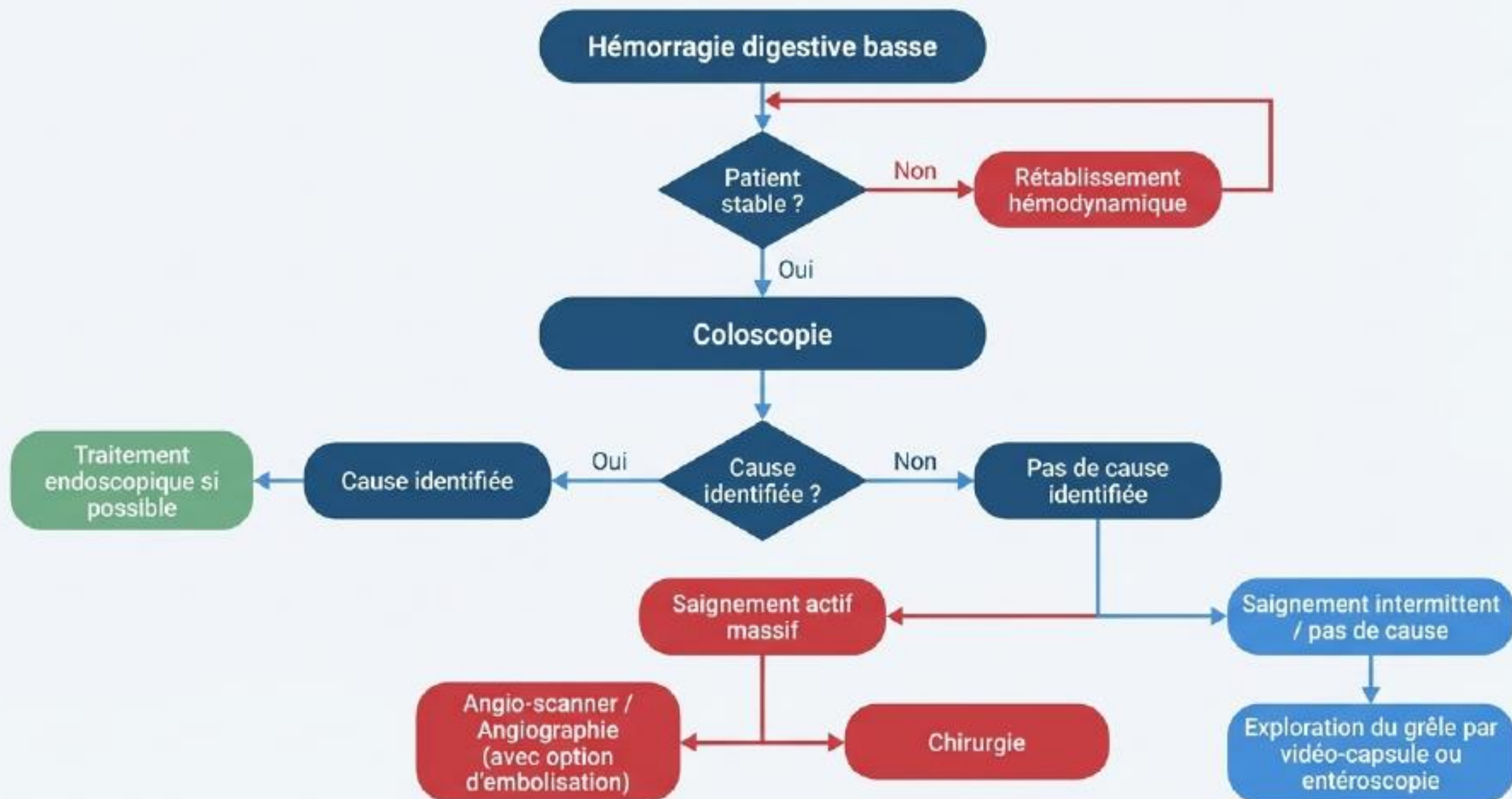
Scintigraphie aux globules rouges marqués



Intérêt limité en urgence.

Utile pour sélectionner les patients pour une artériographie.

La Conduite à Tenir : Algorithme Décisionnel



Les Étiologies : Une Cartographie des Causes Possibles

Causes Intestinales (Grêle) ←

- Diverticule de Meckel
- Tumeurs du grêle
- Lésions dues aux AINS



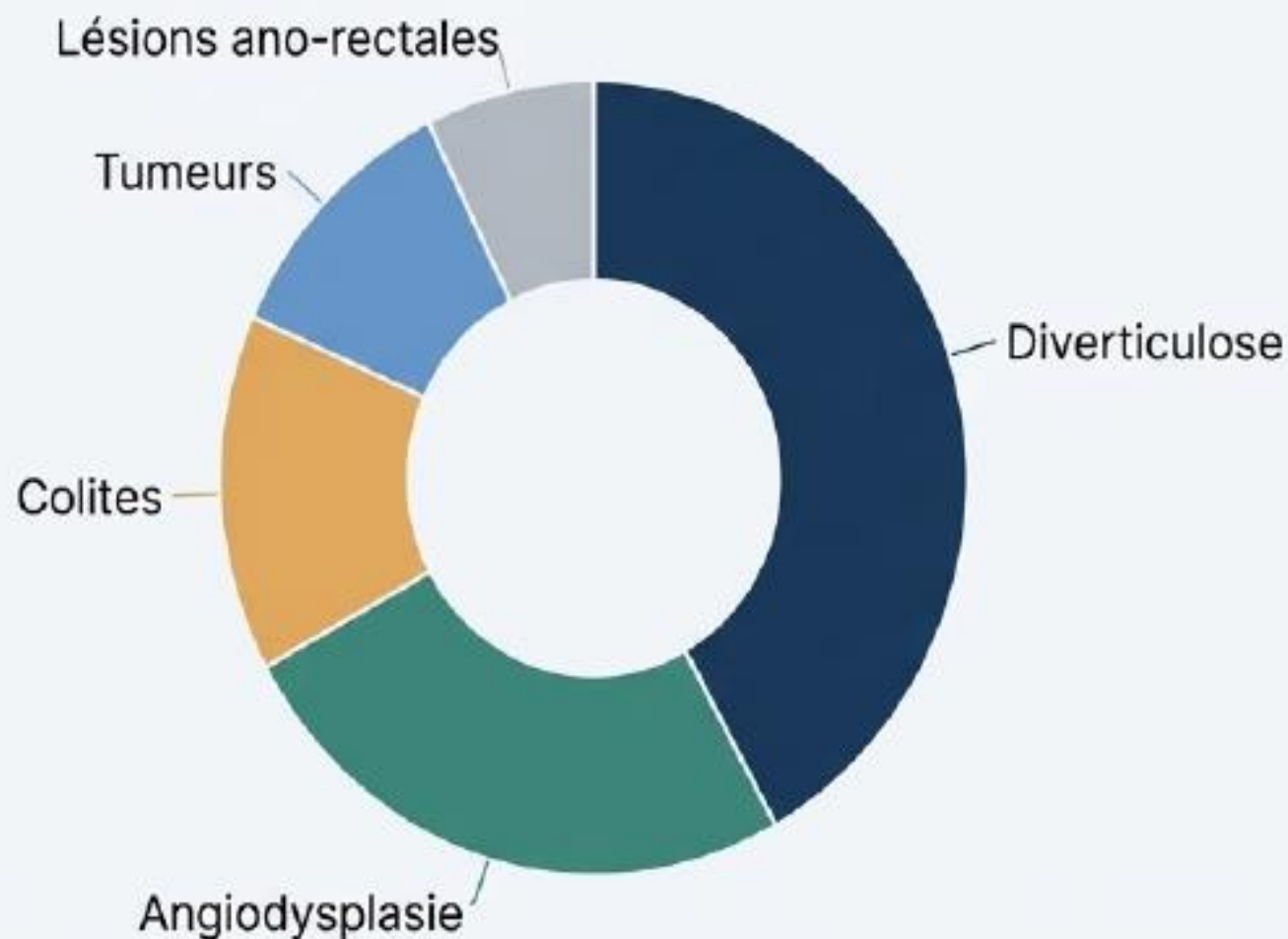
Causes Colo-rectales

- Hémorragies diverticulaires (40% des HDB)
- Angiodysplasie
- Colites (ischémiques, inflammatoires, infectieuses)
- Pathologie tumorale (bénigne et maligne)

Causes Anales

- Hémorroïdes (la plus fréquente)
- Fissure anale
- Cancer anal

Panorama des Étiologies des Hémorragies Digestives Basses



Les Cinq Grandes Catégories :

Diverticulose (La plus fréquente)

Angiodysplasie

Lésions ano-rectales

Colites (de diverses origines)

Tumeurs (bénignes et malignes)

Point de vigilance clinique :



Chez un sujet de plus de 50 ans, la hantise de tout médecin est le **cancer colorectal (CCR)**.

Focus sur les Causes Anales : Les Plus Fréquentes



1. Hémorroïdes

- **Description:** Cause la **plus fréquente** d'HDB, **saignement** souvent minime et intermittent.
- **Clinique:** Rectorragies de **sang rouge**, non mélangées aux selles (**taches sur le papier toilette**).
- **Diagnostic:** Examen proctologique. Une coloscopie est souvent pratiquée pour éliminer une autre cause.
- **Traitement:** Règles hygiéno-diététiques, bains de siège, traitement médical. **Geste endoscopique ou chirurgical** si rebelle.



2. Fissure anale

- **Description:** Ulcération superficielle de la partie sous valvulaire du canal anal.
- **Clinique:** Rectorragie de **sang rouge en fin de selle**, associée à une **douleur en trois temps**.
- **Traitement:** Traitement médical de la constipation, méthodes locales (toxine botulique, dérivés nitrés), **chirurgie (sphinctérotomie)**.

Cancer Anal (Carcinome épidermoïde)



Clinique :

Rectorragie est le symptôme le plus fréquent. Douleurs, troubles du transit, masse anale.



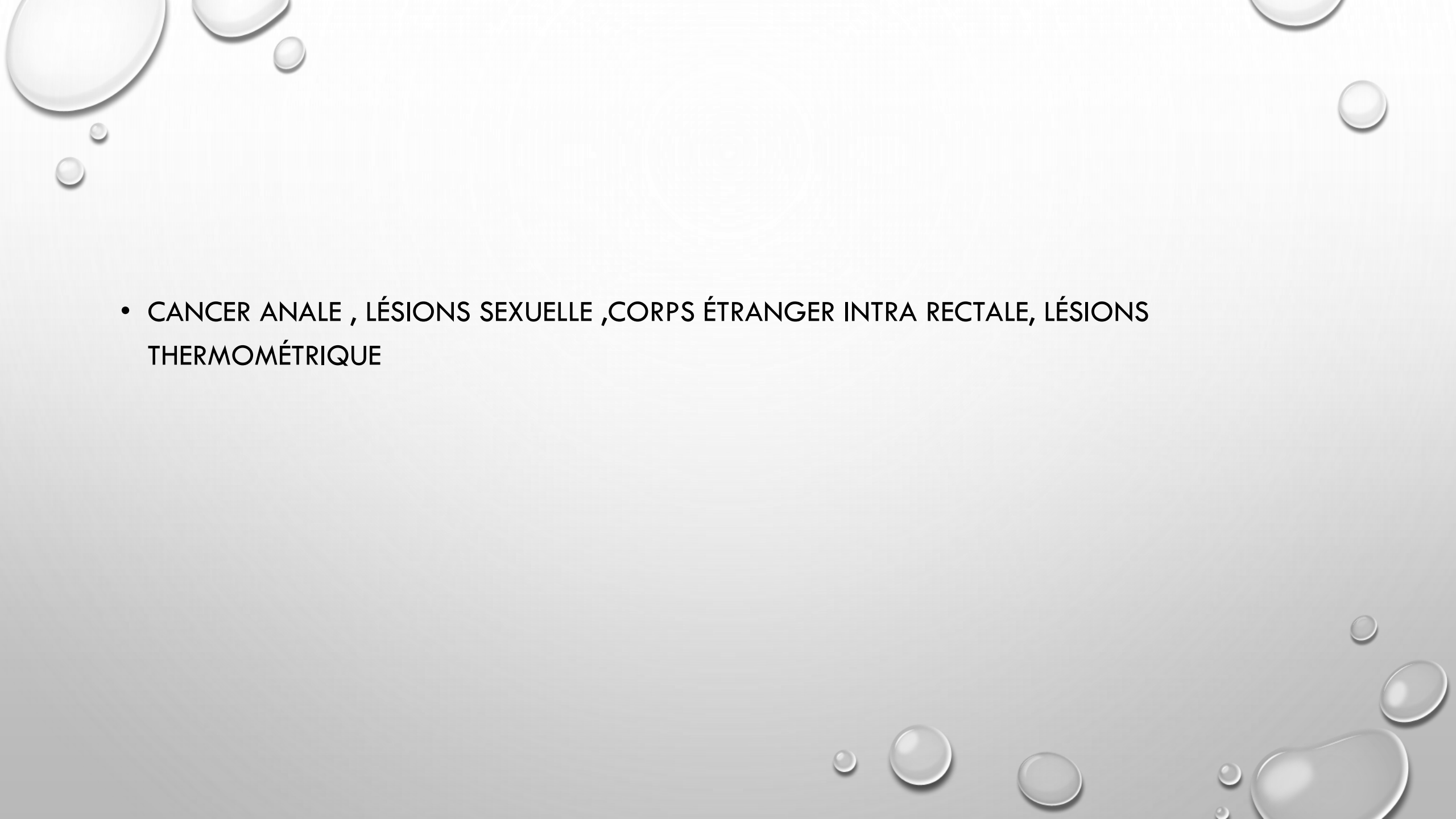
Diagnostic :

Examen proctologique (masse bourgeonnante, induration +++), anoscopie, biopsies.



Traitement :

Radiothérapie, curiethérapies. Chirurgie (amputation abdominopérinéale).

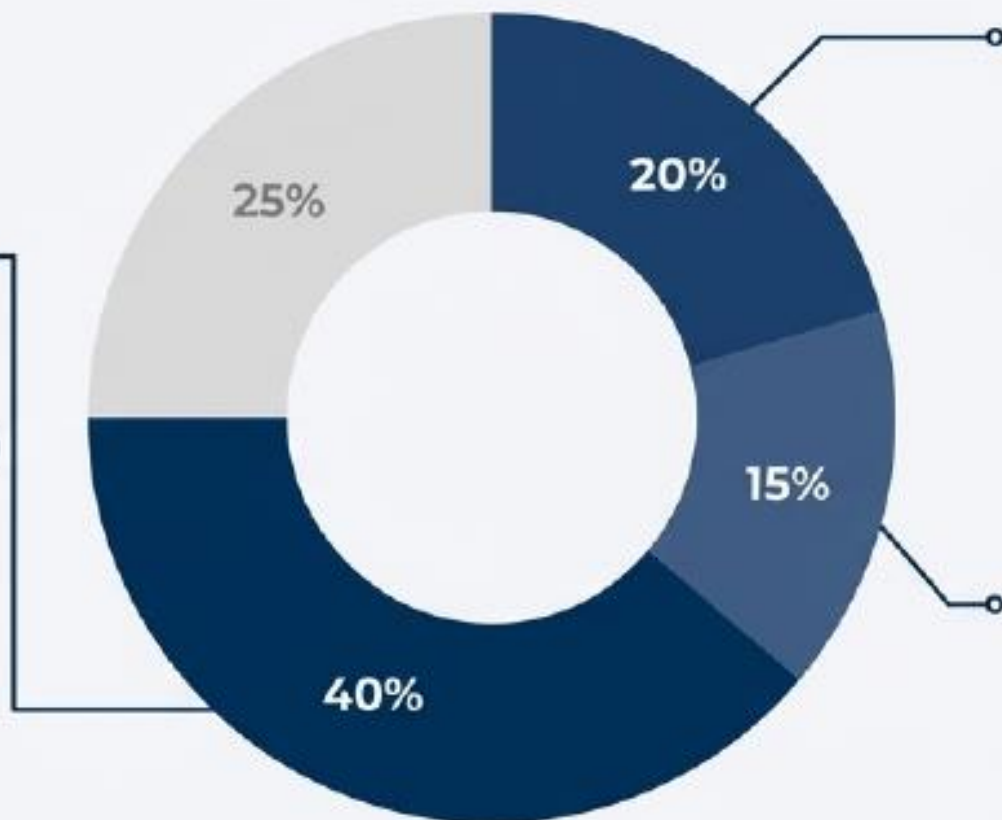
- 
- The background of the slide is a light gray gradient. In the top-left and bottom-right corners, there are several realistic-looking water droplets of various sizes, some overlapping. A faint, circular watermark logo is visible in the upper center of the slide.
- CANCER ANALE , LÉSIONS SEXUELLE ,CORPS ÉTRANGER INTRA RECTALE, LÉSIONS THERMOMÉTRIQUE

Les causes les plus fréquentes : L'origine colorectale (>90%)



Hémorragie diverticulaire (≈ 40%)

Contexte : Sujet âgé, souvent déclenchée par la prise d'AINS.
Clinique : Rectorragies abondantes, aiguës et indolores.



Angiodysplasies (≈ 20%)

Contexte : Sujet très âgé, siège préférentiel sur le colon droit.
Clinique : Saignements récidivants.



Causes tumorales et post-polypectomie (≈ 15%)

Contexte : Adénocarcinome colorectal ou suite d'une résection de polype.
Clinique : Saignement souvent moins abondant, peut être mêlé aux selles ou occulte.

Focus sur les Causes Colo-rectales (1/2) : Diverticulose et Angiodysplasie



1. Hémorragies diverticulaires

40% des
HDB

- **Prévalence:** Liées à la rupture de branches artérielles. Souvent déclenchées par la prise d'AINS.
- **Clinique:** Rectorragies aiguës, indolores, faites de sang rouge vif ou marron.
- **Diagnostic:** Coloscopie montre des signes endoscopiques de saignement au sein des lésions.
Diagnostic: Coloscopie montre de is des lésions.
- **Évolution & Traitement:** Arrêt spontané fréquent. Si récidence ou persistance : traitement endoscopique (injection, coagulation), embolisation, ou colectomie.



2. Angiodysplasie

- **Description:** Lésion dégénérative (dilatation des veines sous-muqueuses). Sujet âgé ++.
- **Clinique:** Rectorragies de sang rouge, méléna, ou anémie ferriprive (saignement occulte).
- **Diagnostic:** Coloscopie (lésions planes, rouges, stellaires). Artériographie si forte suspicion non confirmée.
- **Traitement:** Essentiellement endoscopique (Laser Argon, coagulation).

Focus sur les Causes Colo-rectales (2/2) : Tumeurs et Colites



1. Pathologie Tumorale Recto-colique

- **Tumeurs Malignes:** Adénocarcinome colorectal. Risque important après 50 ans.
 - **Clinique:** **Rectorragies** mêlées ou non aux selles, **méléna**, **AEG**, douleurs abdominales, masse palpable.
 - **Diagnostic & Traitement:** Rectosigmoïdoscopie + coloscopie avec biopsie. Traitement chirurgical +/- radiochimiothérapie.
- **Tumeurs Bénignes:** Adénomes, polypes épithéliaux.



2. Les Colites

- **Ischémiques:** Terrain > 50 ans, athéromateux. **Rectorragies**, douleurs, diarrhée.
- **Inflammatoires (MICI):** RCUH et Maladie de Crohn. **Diarrhée glairo-sanglante**, signes extra-digestifs.
- **Infectieuses:** E.Coli, C. difficile, Salmonelle, etc. **Diarrhée glairo-sanglante**.
- **Radique / Médicamenteuse:** Contexte évident (radiothérapie, AINS).

Élargir l'enquête : Anus, grêle et colites

Causes proctologiques

(fréquentes, mais rarement graves)

- **Maladie hémorroïdaire** : Cause la plus fréquente de rectorragies minimales.
- **Fissure anale** : Douleur typique associée au saignement.

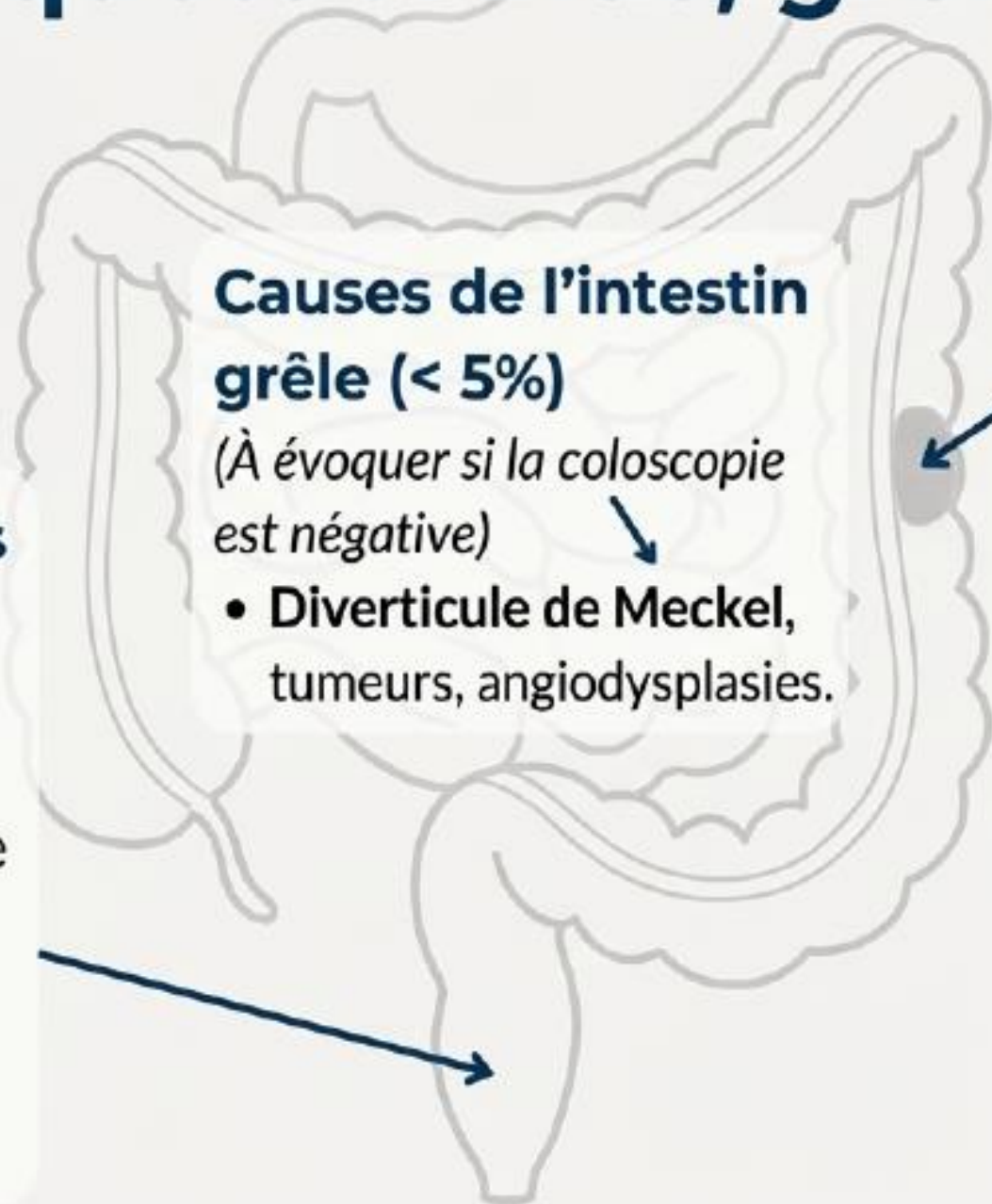
Causes de l'intestin grêle (< 5%)

(À évoquer si la coloscopie est négative)

- **Diverticule de Meckel**, tumeurs, angiodysplasies.

Les colites

- **Ischémique** : Sujet âgé, athéromateux; triade 'douleurs abdominales, diarrhée, rectorragies'.
- **Inflammatoire (MICI)** : Contexte de RCUH ou Crohn; diarrhée glairo-sanglante.
- **Infectieuse** : Amibiase, Shigellose, CMV, etc.



Focus sur les Causes Intestinales : Le Défi du Grêle



1. Diverticule de MECKEL

- **Description:** Anomalie congénitale la plus fréquente du tractus digestif.
- **Clinique:** Souvent asymptomatique. Se révèle le plus souvent avant 2 ans par un **méléna** associé ou non à du **sang rouge**.
- **Diagnostic:** Scintigraphie au technétium 99.



2. Pathologie Tumorale du Grêle

- Bénignes (adénomes) ou Malignes (adénocarcinome, lymphome).
- **Clinique:** Age > 50 ans. Peuvent être responsables d'**HDB**.
- **Diagnostic:** Transit du grêle, entéroscopie avec biopsie, vidéo-capsule.



3. Autres Causes Intestinales

- Lésions dues aux AINS.
- Entérites infectieuses (TBK, typhoïde, CMV).
- Maladie de Crohn.
- Ulcération de Dieulafoy (rare, <1% dans le jéjunum ou l'iléon).

HDB : Les Principes Clés de la Prise en Charge

Synthèse

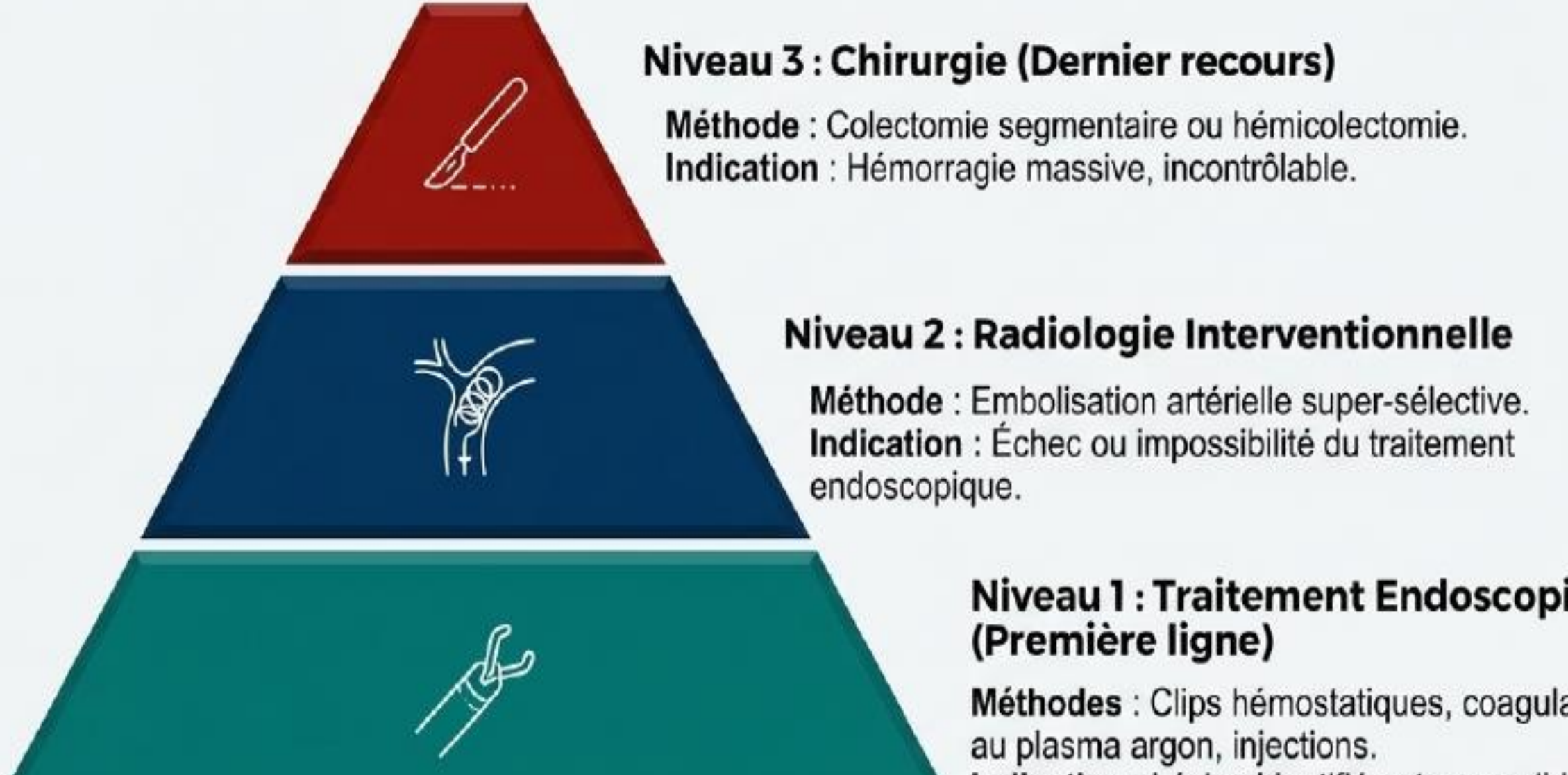
L'hémorragie digestive basse est moins fréquente et généralement moins grave que l'hémorragie haute, mais sa prise en charge doit être rigoureuse et systématique.

La Séquence Gagnante

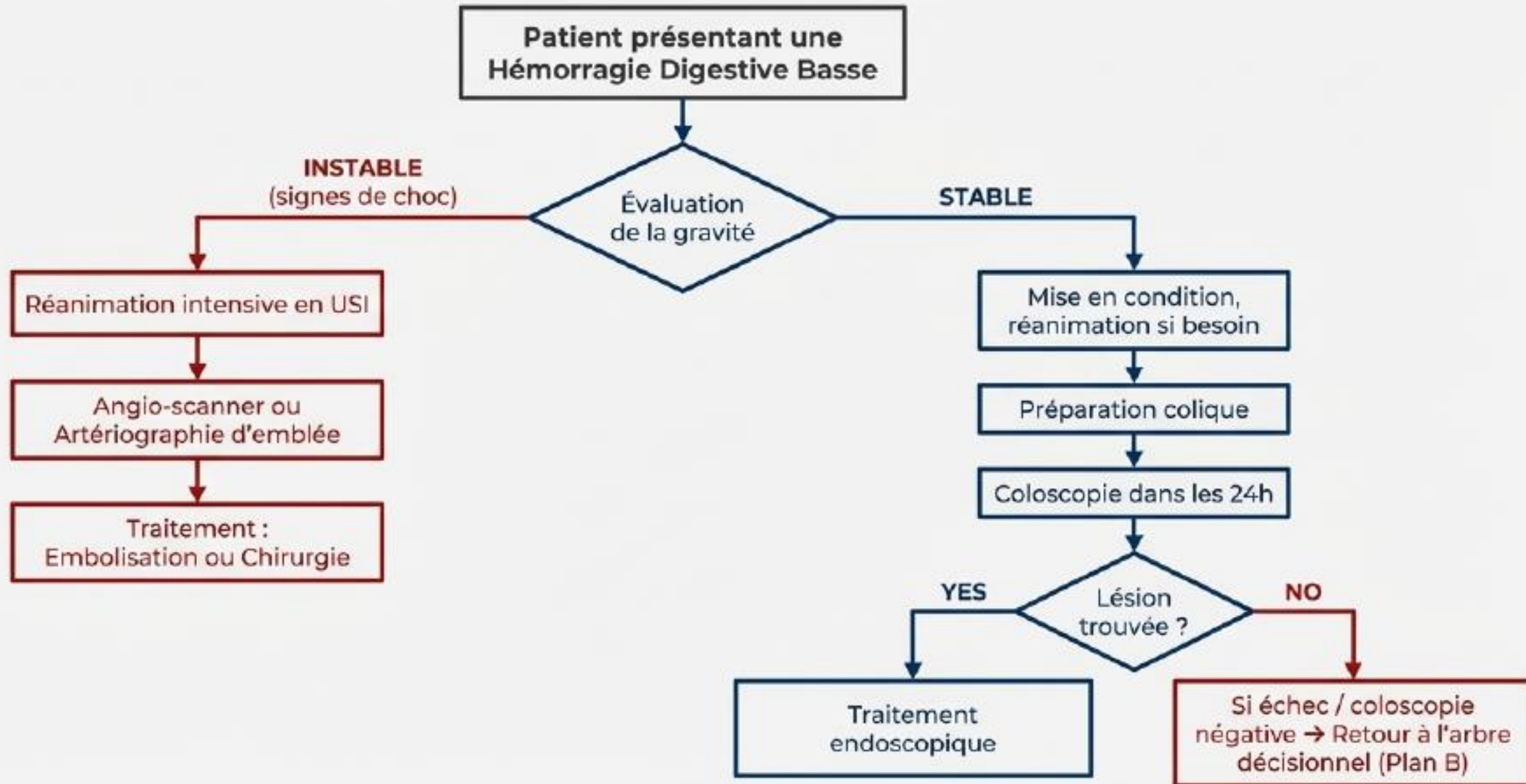


Une approche structurée transforme une situation d'urgence potentiellement chaotique en une investigation méthodique menant à un traitement efficace.

L'arsenal thérapeutique : Une approche graduée



Votre feuille de route : L'algorithme de prise en charge



Points Clés à Retenir

- 1. Priorité à l'Hémodynamique :** L'HDB est une urgence médico-chirurgicale. La stabilisation du patient prime **TOUJOURS** sur le diagnostic étiologique.
- 2. La Coloscopie est l'Examen Roi :** Elle est à la fois diagnostique, pronostique et thérapeutique. Sa réalisation précoce après réanimation améliore les résultats.
- 3. La Démarche est Systématique :** Suivre l'algorithme permet une prise en charge structurée, des gestes simples (Toucher Rectal) aux examens les plus complexes.
- 4. Penser Pluridisciplinaire :** La prise en charge est une collaboration essentielle entre urgentistes, réanimateurs, gastro-entérologues, radiologues et chirurgiens.